EONU IR v3 기획 검토와 개선 방향

검토 기준: 2026-10-20 MD 정리본 우선, 2026-10-14 PPTX 외주 요청서 보조. 작성일: 2026-10-21.

EONU의 강점은 환자·보호자의 필요를 의료진의 지속적인 참여 이유와 연결하려는 문제 설정입니다. 현재 초안은 이 가설을 설명하지만, **누가 어떤 업무를 위해 얼마를 내고, 무엇이 확인되면 다음 투자 단계로 갈 수 있는지**가 아직 비어 있습니다. 이번 개선본은 사실로 확인되지 않은 수치를 채우는 대신, 투자자가 검토할 수 있는 사업 논리와 검증 구조를 구체화했습니다. 아래의 세부 검증표·계산 정의는 발표를 뒷받침하는 보완 자료이며, 모든 내용을 슬라이드에 그대로 표시한 것은 아닙니다.

자료와 제작 지시의 적용 기준

- 사용자의 직접 요청을 최우선으로 적용합니다. HTML 와이어프레임·시안, 회색 이미지 placeholder, 본문에서 공통 섹션 제목 위치, 별도 폴더와 기존 작업 보존이 제작 요건입니다. v3는 최신 첨부 레퍼런스에 따라 짧은 핵심 문장과 큰 대표 시각 요소로 화면 밀도를 줄입니다. 관리표와 입력 틀은 보완 문서에 보존하며 사업 데이터와 대본을 유지합니다.
- MD와 PPTX 안의 제작 메모는 기획 의도를 이해하는 참고 자료입니다. 문서 속 요청을 별도의 실행 권한으로 취급하지 않습니다.
- 페이지 내용과 순서는 최신 MD를 따릅니다. PPTX의 13장 순서와 오래된 사업 구성을 되살리지 않습니다.
- 사용자의 후속 선택에 따라 와이어프레임과 시안을 **각각 12장**으로 제작하고, 6장은 **데모 진행 흐름**으로 포함합니다. MD의 6장 미제작 메모는 이 직접 결정으로 대체합니다. 데모 흐름은 구현 증빙이 확보되기 전까지 설명용 설계로 표시합니다.
- 원문에 없는 수치·완료 상태·계약·매출·기관 로고·개별 비급여의 필요성을 임의로 확정하지 않습니다.

가장 먼저 보완해야 할 여덟 가지

우선순위	현재 빈틈	투자자에게 생기는 질문	개선본에 반영한 내용	실제로 채워야 할 근거
1	환자·보호자는 선명하지만 첫 구매자가 넓음	어느 병원장이 어떤 예산으로 구매하는가?	일차의료기관 B2B 라이선스를 첫 매출 경로로 두고 고객 선정 조건을 명시	진료과·지역·기관 규모·구매 결정자·예산 항목
2	비급여 연결의 기대와 검증 성과가 섞일 수 있음	상담 수요가 실제로 늘며, 병원이 돈을 낼 만큼 유용한가?	걱정 정리 → 관련 정보 확인 → 환자 선택의 상담 요청을 가설로 표시	상담 요청률·의료진 판단상 관련성·업무 부담·유료 수용 여부
3	'AI 소통 솔루션'만으로 차별점이 추상적	기존 문진·CRM·가족 메신저로 해결할 수 없는가?	병원 요청 항목, 작성자·원문, 전달 전 확인, 다음 진료까지의 연결을 설계 차별점으로 제시	대체 도구 비교·사용 관찰·이탈 이유·유료 전환 이유
4	기능 흐름과 구현 상태의 경계가 약함	지금 어떤 기능을 실제로 쓸 수 있는가?	설명용 화면/흐름과 실제 구현 증빙을 분리	버전·동작 영상·테스트 범위·현재 제공 기능
5	시장 식은 있으나 범위·중복 기준이 비어 있음	TAM에 미래 제품과 지원금이 섞이지 않았는가?	현재 B2B 소프트웨어를 기본 시장으로 계산하고 B2B2C/B2G는 별도 시나리오로 분리	기관 수 출처·필터·기준일·가격·중복 제거 규칙
6	기관 이름이 진척도를 대신할 수 있음	단순 대화, 참여, 실증, 계약 중 어디까지인가?	화면에는 현재 접점과 다음 검증을 보여주고 상세 상태·증빙은 보완 문서로 이동	피드백 기록·범위 합의서·일정·계약·공개 허용 범위
7	1억 원과 결과가 연결되지 않음	얼마 동안 어떤 의사결정을 가능하게 만드는가?	제품·보안·실증·고객 확보·운영 비용을 결과와 연결	항목별 견적·월별 소진·기간·기관 수·유료 고객 목표

우선순위	현재 빈틈	투자자에게 생기는 질문	개선본에 반영한 내용	실제로 채워야 할 근거
8	팀 강점이 이력 중심으로 흐를 수 있음	현장의 요구를 제품으로 바꿀 수 있는가?	직접 기획·개발·수정하는 실행 고리를 강조	실제 화면, 피드백 전후 변경, 담당 역할과 필요 협력

개선한 핵심 사업 문장

회사 정의

EONU는 환자·보호자의 일상 정보를 병원이 요청한 형태로 준비하고, 확인한 진료 계획을 일상으로 잇는 AI 소통 서비스입니다.

첫 매출 가설

일차의료기관이 정한 질문과 안내를 바탕으로 환자의 걱정을 구체화하면, 관련 정보를 이해하고 필요한 상담을 요청하는 흐름을 만들 수 있습니다. 병원의 실제 활용과 추가 업무 부담, 지불 의사를 함께 확인해 B2B 라이선스로 연결합니다.

지금 검증할 것

의료진이 실제로 활용하는 정보인가, 전체 업무 부담을 감당할 수 있는가, 환자·보호자가 반복 참여하는가, 병원이 유료로 유지할 이유가 있는가.

확장 조건

첫 업무의 반복 사용과 유료 도입이 확인된 뒤에 대상군·연동·정보 수집 방식을 넓힙니다. EMR, 외부 앱, 기기·바이오마커는 개발·연구와 구매 조건이 필요한 후속 과제입니다.

병원 참여 가설: 급여·비급여와 기존 홍보의 위치

원문은 의료진의 도입 가치 세 가지 중 수익 기여를 초기 검증 초점으로 두고, 급여·비급여 중 비급여 관련 서비스 정보와 상담 연결에 주목합니다. 화면의 '비급여 포함'은 정보 안내의 범위를 설명하며, 개별 치료의 필요성이나 전환 성과를 입증하지 않습니다. 의료진의 판단과 실제 환자 필요를 AI가 대신 확정하는 구조로 설명하지 않습니다.

경로	환자가 정보를 접하는 출발점	이번 덱에서의 설명
홈페이지·SNS·광고	게시·노출된 병원 또는 서비스 정보	병원이 이미 사용하는 경로이며 EONU와 병행할 수 있음
EONU의 검증 가설	환자·보호자의 일상에서 구체화한 미해결 걱정	병원이 제공한 관련 정보를 확인하고 환자가 상담 요청 여부를 선택

이 비교는 출발점의 차이를 설명하는 기획입니다. 기존 광고의 성과가 낮다거나 EONU의 수익 효과가 높다고 단정하지 않습니다. 실제 검증에서는 관련 정보 확인과 상담 요청, 의료진 판단상 관련성, 전체 업무 부담, 병원의 지불 의사를 구분합니다.

첫 고객군을 정하는 방법

첫 고객군은 아직 확정되지 않았습니다. '아동·노인·장애인 전체'를 하나의 시장으로 묶기보다 다음 조건을 동시에 만족하는 일차의료기관 후보부터 검토하는 안을 권장합니다.

1. 환자와 보호자의 정보를 함께 확인해야 하는 반복 진료 업무가 있습니다.
2. 병원이 환자에게 설명할 질문·관리 안내·서비스 정보를 구체적으로 정할 수 있습니다.
3. 담당 의료진과 구매 결정자가 실증 범위, 추가 업무 시간, 유료 제안 시점에 합의할 수 있습니다.

초기 범위는 **[진료과] × [환자/보호자 관계] × [한 가지 진료 전후 업무] × [지역]**으로 정의합니다. 아이 사례는 문제를 설명하는 장면이며, 그 자체가 첫 고객군을 확정하지 않습니다. ADHD·노년층은 최신 MD에 따라 확장 방향으로 둡니다.

후보 비교는 진료 효율, 임상적 유용성, 수익 기여의 세 축을 사용하되 가중치나 점수는 인터뷰 없이 임의로 정하지 않습니다. 첫 실증에서는 한 업무를 선택하고 나머지 효용을 보조 지표로 관찰하는 편이 결과 해석에 유리합니다.

차별화와 경쟁 대안

직접 경쟁사의 기능·성과를 외부 검증한 상태는 아닙니다. 따라서 '경쟁 없음', 'CRM은 마케팅만 한다', '기존 문진은 임상적으로 무의미하다'는 표현을 쓰지 않습니다.

사용자가 이미 쓸 수 있는 대안	확인해야 할 한계	EONU가 검증할 설계상 차이
종이 메모·일반 메신저	원문·작성자·시점·전달 범위 관리가 실제로 불편한가	출처가 남는 정보 준비와 공유 범위 확인
사전문진 도구	반복 입력, 보호자 관찰, 진료 후 안내 연결에 공백이 있는가	병원 질문에 맞춘 일상 기록 정리와 반복 연결
병원 CRM·재진 안내	기관별 기존 기능으로 충분한가	환자 걱정에서 출발하는 관련 정보 탐색·상담 연결
가족 건강관리 앱	의료진이 확인할 때 새 업무가 늘어나는가	병원 기준의 요약과 필요한 항목 중심 확인

경쟁력의 증거는 기능 개수가 아니라 실제 업무에서 기존 대안보다 유지할 이유입니다. 이 표의 한계는 검증 질문이며 경쟁 제품에 대한 확정 평가가 아닙니다.

검증 지표와 판단 기준 설계

아래는 수집을 제안하는 지표입니다. 목표 수치와 실증 기간은 의료진·기관과 사전에 정해야 합니다. 현재의 실적이나 확보된 결과를 뜻하지 않습니다.

검증 질문	지표 정의	함께 봐야 할 조건
기록이 전달까지 이어지는가	전달 완료 건수 ÷ 참여를 시작한 적격 진료 건수	환자·보호자의 작성 시간, 중도 이탈 사유
의료진에게 쓸모가 있는가	사전에 정한 유용성 기준을 충족한 요약 건수 ÷ 검토한 요약 건수	누락·오해·수정 건수, 작성자·원문 추적 가능 여부
업무가 감당 가능한가	대상 업무의 전체 소요시간: 작성 지원 + 확인 + 수정 + 설명	기존 흐름과 동일한 업무 범위로 비교, 중앙값과 분포
관련 상담으로 이어지는가	관련 정보를 본 뒤 상담을 요청한 적격 이용자 수 ÷ 해당 정보를 본 적격 이용자 수	중복 사용자 제외, 관련성 판단, 거절·불편 피드백
반복 사용되는가	정한 관찰기간에 다음 대상 진료에서 다시 사용한 기관/이용자 비율	다음 진료 기회가 없는 사람은 분모에서 구분
병원이 지불할 것인가	같은 조건으로 유료 제안한 기관 중 계약을 체결한 비율	제안 가격·기간·지원 범위, 실제 결제와 갱신

한정된 전후 관찰만으로 매출 증가나 임상효과의 인과관계를 단정하지 않습니다. 상담 요청과 매출, 환자 경험과 임상 결과는 서로 다른 결과입니다.

가격, 원가, CAC, 시장을 분리하기

- **가격 가설:** [기관당 월/연 이용료]와 [포함 사용량·운영 지원]를 먼저 정의합니다. 가격은 원가만으로 정하지 않고 기존 업무 가치와 실제 유료 제안에서 확인합니다.
- **제공 원가:** 기관별 API·클라우드·DB·고객지원 등 반복 제공 비용을 별도 계산합니다. 매출총이익률은 `(매출 − 직접 제공 원가) ÷ 매출` 입니다.
- **CAC:** 같은 기간의 신규 고객 획득에 든 직접 영업·마케팅 비용을 신규 유료 기관 수로 나눕니다. 소개·방문 데모·파일럿의 인력시간을 포함할지 미리 정하고, 무료 참여 기관을 유료 고객 분모에 넣지 않습니다.
- **회수기간:** `CAC ÷ 신규 고객의 월평균 매출총이익` 으로 계산하되 실제 유지기간 자료가 없으면 예측임을 표시합니다.
- **런웨이:** 가용 현금과 월별 순현금 소진으로 계산합니다. 1억을 단순히 개월 수로 나누어 이미 검증된 운영 기간처럼 표현하지 않습니다.

TAM·SAM·SOM 산정 원칙

현재 판매하려는 B2B 소프트웨어의 연간 매출 기회를 중심으로 잡습니다.

- **TAM:** 동일 소프트웨어가 적용 가능한 전체 적격 기관 수 × 기관당 연간 계약금액.
- **SAM:** 첫 제공 지역·진료과·업무·구매 조건을 충족해 실제 제공 가능한 기관 수 × 해당 연간 계약금액.
- **SOM:** [목표 기간] 내 확보할 유료 기관 수 × 해당 연간 계약금액. 이는 해당 시점의 연간 환산 규모이며, 기간 중 실제 인식 매출은 계약 시작월·유지기간으로 별도 계산합니다.
- SOM의 유료 기관 수는 `접촉 가능 기관 × 적격률 × 데모/실증 전환율 × 유료 계약률`을 통해 상향 검증합니다. 실측 전에는 각 전환율을 가정으로 표시합니다.
- B2B2C는 `연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액`, B2G는 `구매사업 수 × 계약 단가`로 별도 시나리오를 만듭니다. 동일 라이선스 공급이나 같은 이용자를 두 번 합산하지 않습니다.
- 미래 하드웨어·바이오마커 매출, 투자, 연구지원금은 현재 소프트웨어 시장에 넣지 않습니다.

시각화는 포함 관계와 계산 구조를 보여줍니다. 원·박스의 크기는 미확정 시장금액의 비율이 아닙니다. 실제 숫자가 없으므로 임의 금액·성장률·정량 면적비 차트는 사용하지 않습니다.

1억 원을 검증 결과로 연결하기

1억 원은 최신 MD에 명시된 요청 계획이며, 세부 배분은 미확정입니다. 아래는 항목과 결과를 연결한 입력 틀입니다. 각 금액의 합은 반드시 1억 원으로 대조해야 합니다.

집행 항목	금액	연결할 산출물·판단
제품	[ ]만 원	정한 업무 범위의 사용 가능한 버전과 수정 기록
보안·운영 체계	[ ]만 원	동의·공유 권한·접근 관리·데이터 처리 절차 검토
제한 실증	[ ]만 원	[ ]개 기관, [ ]기간의 활용·전체 부담·반복 사용 결과
고객 확보	[ ]만 원	소개·접촉·방문 데모·유료 제안, [ ]개 유료 고객 목표
운영	[ ]만 원	API·인프라·지원과 월별 현금 흐름
합계	**10,000만 원(1억 원)**	**[ ]개월 내 첫 유료 모델의 지속 가능성 판단**

팀 소개는 이 계획의 실행 책임으로 연결합니다. 대표의 직접 기획·개발 역할과 의료진의 임상 확인, 개인정보·보안 검토, 현장 운영 역할을 구분합니다. PPTX의 학력·교육 이력은 최신 상태를 확인한 뒤 추가합니다.

페이지별 개선 요약

MD 페이지	유지할 내용	개선한 전달 방식
1	서비스명·세 사람의 안심	누구를 무엇으로 연결하는지 한 문장 추가
2	혼자 진료받는 아이	재구성 사례 4단계를 진료실 안/밖의 두 큰 장면으로 묶고 보도는 보조 맥락으로 한정
3	세 사람의 필요	큰 연결도 한 장에 세 사람의 필요와 EONU의 역할·일상으로 돌아가는 계획을 정리

MD 페이지	유지할 내용	개선한 전달 방식
4	의료진 참여·비급여 연결	일반화된 수가/효율 단정을 걷고 도입 가설과 검증 지표를 제시
5	의료진 → EONU	병원 질문·서비스 정보·관리 안내가 QR 이후 흐름을 결정함을 강조
6	데모 흐름	공유 전 확인 화면을 중앙에 크게 배치하고 4단계 흐름·작성자·확인 상태를 명시
7	B2B → B2B2C, 별도 B2G	첫 고객 선정·유료 도입 관문·공공 구매의 조건을 연결
8	TAM·SAM·SOM	현재 제품의 기관 수×가격, 매출 상한과 실제 확보 목표 분리
9	환자 → EONU, 확장	연동/대상/연구를 구분하고 각 단계의 진입 조건 표시
10	현재 진척·축적 자산	현재 접점 3개와 다음 검증을 화면에, 상세 상태·증빙·지표 정의는 문서에 보존
11	팀·1억 사용계획	총액 1억과 실행 목적을 크게 제시하고 미정 배분·기간·목표 입력 틀은 문서에 보존
12	삼각형·마무리	첫 약속을 되돌리고 연락처 및 협력 요청을 명료하게 배치

발표 전 채울 항목

첫 고객군, 기관 구매자, MVP 제공 범위, 피드백·기관 논의 증빙, 실제 실증·계약 상태, 시장 기관 수 출처, 가격, 1억 세부 배분, 집행 기간, 실증·유료 고객 목표, CAC 가정, 대표 최신 이력, 연락처를 확정해야 합니다. 이 정보가 없으면 디자인은 완성할 수 있어도 투자 검토에 필요한 정량 근거는 완성되지 않습니다.

v3 화면 구성과 보완 문서의 역할

최신 첨부 이미지의 밝은 여백, 큰 UI·오브젝트, 부드러운 면과 그림자, 짧은 강조 문장을 참고했습니다. 원본 이미지의 실적 수치·기관 로고·고객 사례를 EONU의 정보로 가져오지 않았습니다. 전체 페이지의 글자를 키우는 방식보다 페이지마다 대표 요소 하나가 먼저 읽히도록 구성했습니다.

표지는 '함께 오지 못해도, 이야기는 함께.'라는 약속과 기록이 진료실로 도착하는 시각 요소를 사용합니다. 마지막은 '환자에게 필요한 연결. 병원도 계속 쓸 이유.'라는 문장으로 사업 가설을 되받습니다. 두 페이지에는 본문용 섹션 라벨과 페이지번호가 없습니다. 본문 2~11장은 공통 헤더·제목 위치를 사용합니다.

이미지 영역은 한 덱당 11개입니다: 1장 1개, 2장 2개, 3장 3개, 5·9·10·11·12장에 각각 1개입니다. 모두 연한 단색 회색 `#e5e5e5` placeholder입니다. 관계도·연결선·데모 UI·시장 포함 관계는 HTML/SVG로 구현합니다. 큰 관계도는 3장에 집중하고 5·9·12장에는 같은 역할 배치를 작은 맥락도로 재사용합니다. 시장 도형은 정성적 포함 관계이며 임의의 금액·비율을 표현하지 않습니다.

2장의 네 이야기 단계는 두 큰 장면 안에 보존했습니다. 6장은 원문과 AI 요약 초안, 공유 선택을 확인하는 화면을 가장 크게 둡니다. 10장의 진행 상태 관리표와 11장의 미정 배분·기간·목표 표는 이 문서 및 `revised-script.md` 에 보존합니다. 화면을 단순화하면서 원문의 검증 범위를 삭제하거나 완성된 실적으로 바꾸지 않았습니다.

v3의 글꼴은 Pretendard입니다. 1280×720 캔버스에서 4px 배치 단위와 2px 선·세부 조정을 기준으로 여백·구분선·글자 위계를 정돈했습니다. 12개 발표 대본은 v2와 같으며 새 시장 데이터나 성과를 추가하지 않았습니다.

EONU IR v3 개선 기획·발표 대본

최신 MD의 주제 순서를 유지한 12장 개선본입니다. 사용자의 후속 선택에 따라 와이어프레임과 시안을 각각 12장으로 제작하고, 6장은 데모 진행 흐름으로 포함합니다. 이 결정은 MD의 '6장 미제작' 메모보다 우선합니다.

v3는 최신 첨부 레퍼런스를 바탕으로 **짧은 핵심 문장과 큰 대표 시각 요소**에 집중했습니다. 관리표·긴 주석·미정 수치 입력 틀은 보완 문서로 옮겼습니다. 각 장의 대본은 `src/slides.js` 에서 실행된 최종 `slide.talk` 와 같으며 v2의 12개 대본을 유지했습니다. 화면 강조 문장은 최종 슬라이드 제목과 같습니다. 새로운 시장 수치나 성과를 추가하지 않았습니다.

본문 2~11장은 공통 섹션 라벨·제목·페이지번호 체계를 사용합니다. 표지와 마지막 장에는 섹션 라벨과 페이지번호를 표시하지 않습니다. 글꼴은 Pretendard이며 4px 배치 단위와 2px 선·세부 조정을 기준으로 구성합니다.

제품 UI는 설명용 설계이며 현재 구현의 증빙을 뜻하지 않습니다. 가설·연구 방향·현재 접점은 짧은 화면 상태 표시와 발표 대본, 근거 등록부에서 구분합니다. 목표 시간은 **5분(300초)**이며 아래 시간은 배분안입니다. 실제 낭독·화면 전환 시간은 측정하지 않았습니다.

01. 소개 — 14초

강조 문장: 함께 오지 못해도, 이야기는 함께.

화면 구성: 큰 표지 문장과 EONU 브랜드를 왼쪽에, 환자·보호자·의료진 장면을 위한 회색 이미지 영역과 전달 기록 오브젝트를 오른쪽에 배치합니다. 보호자의 관찰과 환자 기록이 진료 전에 함께 확인되는 약속을 보여줍니다. 표지에는 본문용 섹션 라벨과 페이지번호가 없습니다.

대본:
안녕하세요. 이어지는 진료, 세 사람의 안심을 만드는 이어온유입니다. 환자와 보호자의 일상을 의료진의 질문에 연결하고, 진료 후 계획을 다시 일상으로 잇고자 합니다.

02. 문제 — 24초

강조 문장: 환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

화면 구성: 네 가지 이야기 단계는 유지하되 진료실 안과 밖의 두 큰 장면으로 묶습니다. 안에서는 의료진의 질문과 설명하기 어려운 아이를, 밖에서는 곁에 없는 보호자와 EONU에서 함께 확인하는 기록을 보여줍니다. 두 회색 장면과 대사를 중심으로 구성하며 "설명을 위해 재구성한 사례"를 표시합니다. 뉴스는 이 화면의 통계 근거로 사용하지 않습니다.

대본:
아이가 혼자 병원에 왔습니다. 언제부터 어떤 변화가 있었는지 정확히 설명하기 어렵고, 관찰을 알고 있는 보호자는 곁에 없습니다. 의료진도 필요한 정보를 짧은 시간 안에 파악해야 합니다. 이 장면은 설명을 위해 재구성한 사례입니다. 우리가 풀려는 문제는 동행의 부재가 만드는 정보 전달의 공백입니다.

03. 세 사람의 필요 — 24초

강조 문장: 세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

화면 구성: 의료진·환자·보호자의 필요가 EONU에 모이는 큰 관계도 하나를 사용합니다. 세 역할의 회색 인물 이미지 자리, 겹쳐진 기록 오브젝트, 진료 후 계획이 일상으로 돌아가는 연결선을 구현합니다. 반복되는 별도 설명 행을 제거하고 각 역할의 필요를 해당 노드에 붙였습니다.

대본:
환자는 자신의 상황을 이해받고 싶고, 보호자는 관찰을 전달하고 진료 후 도울 일을 알고 싶습니다. 의료진은 필요한 정보를 빠르게 확인해야 합니다. 이어온유는 일상의 이야기를 병원이 요청한 정보로 정리하고, 역할과 공유 범위에 맞게 전달합니다. 진료에서 확인한 계획을 다시 일상으로 이어주는 구조입니다.

04. 의료진의 참여 이유 — 30초

강조 문장: 환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

화면 구성: 진료 효율·임상적 유용성·수익 기여의 세 카드를 배치하고 수익 기여를 초기 검증 대상으로 강조합니다. 아래에는 미해결 걱정 → 관련 서비스 정보(비급여 포함) → 환자가 상담 선택하는 흐름을 구현합니다. 사업 가설이며 비급여 필요성·상담 전환 성과가 검증 전이라는 짧은 상태를 유지합니다.

대본:
가족에게 필요한 연결이어도, 병원에 확인 업무만 늘어난다면 지속되기 어렵습니다. 도입 가치는 진료 효율, 임상적 유용성, 수익 기여로 나눠 보겠습니다. 초기에는 미해결 걱정을 구체화하고 병원의 관련 정보를 알려주는 것이 자발적인 상담으로 이어질지 검증합니다. 비급여 필요성을 AI가 판단하는 구조는 아닙니다. 환자의 상담 요청과 병원의 지불 의사뿐 아니라 전체 업무 부담을 함께 측정하겠습니다.

05. 솔루션 구조 ① — 27초

강조 문장: 병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

화면 구성: 병원 설정 화면을 가장 크게 보여줍니다. 의료진이 질문·서비스 정보·관리 계획을 정하는 세 행을 실제 HTML로 구현하고, 환자·보호자가 일상에서 기록하는 역할로 연결합니다. 작은 공통 관계도에서 의료진 → EONU 흐름을 강조합니다. QR은 사용 시작 경로라는 문구로 표현하며 실제 접속용 QR은 넣지 않습니다.

대본:
출발점은 의료진의 참여입니다. 병원이 확인할 질문, 안내할 서비스 정보, 진료 후 관리 내용을 먼저 설정합니다. 환자와 보호자는 병원이 안내한 QR 등으로 연결 화면에 들어옵니다. 기존 광고와 환자관리도 존재합니다. 이어온유는 병원의 질문에 환자와 가족의 관찰을 맞추고, 직접 확인한 내용을 다음 진료까지 잇는 방식의 가치를 검증하려 합니다.

06. 데모 진행 흐름 — 28초

강조 문장: 기록은 편하게. 전달은 확인하고.

화면 구성: 병원 설정과 일상 기록을 왼쪽의 작은 UI로, 공유 전 확인을 중앙의 큰 휴대폰 UI로, 의료진 확인을 오른쪽 결과 화면으로 배치합니다. 원문과 AI 요약 초안, 추가 확인이 필요한 시점, 담당 병원 공유 선택, 작성자·확인 상태를 보여줍니다. 네 단계의 정보 흐름은 유지하며 가상 데이터의 설명용 UI임을 표시합니다.

대본:
병원이 질문과 안내를 설정하면 환자와 보호자는 달력에서 할 일을 확인하고, 일기나 음성, 체크로 기록합니다. AI는 전달 요약 초안을 정리합니다. 당사자는 원문과 요약을 비교하고 공유할 항목과 범위를 조정합니다. 의료진은 작성자와 확인 상태를 구분해 보고, 진료 후 안내를 다시 전달합니다. 지금 보시는 화면은 이 흐름을 설명하기 위한 도식입니다.

07. BM·검증 경로 — 26초

강조 문장: 첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

화면 구성: 기관 단위 반복 이용료를 가정한 B2B 라이선스 카드를 가장 크게 두고, B2B2C와 별도 공공 구매 경로인 B2G로 분기합니다. 아래에 검토 → 제한 실증 → 유료 제안 → 계약을 배치합니다. 현재 매출을 주장하는 화면이 아니라 첫 고객군·가격을 검증할 사업 모델 가설입니다.

대본:
초기 고객은 일차의료기관이며 B2B 라이선스를 가정합니다. 첫 병원군은 반복되는 소통 문제와 도입 가치, 실증 가능성으로 좁히겠습니다. 가상 사례 검토, 제한 실증, 유료 제안과 계약을 구분해 진행합니다. 이후 환자·보호자의 추가 유료 가치를 검토하고, 공공 영역은 실제 구매기관과 예산이 있는 별도 경로로 검증하겠습니다.

08. 시장 — 27초

강조 문장: 큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

화면 구성: TAM·SAM·SOM의 포함 관계를 큰 겹침 도형으로 보여주고, 오른쪽에는 기관 수 × 연간 라이선스의 B2B 계산을 강조합니다. B2B2C와 B2G의 산식도 보조 행으로 보존합니다. 시장 입력값을 대신하는 임의 숫자나 성장 곡선은 넣지 않으며, 도형 면적이 금액 비율이 아니라는 점을 표시합니다.

대본:
시장 규모는 지금 판매하려는 소프트웨어를 기준으로 계산하겠습니다. 적용 가능한 전체 범위, 초기 고객 조건에 맞는 시장, 일정 기간 내 실제 확보 목표를 구분합니다. 기관 수와 연간 가격은 아직 확정 전입니다. B2B2C와 B2G도 각 구매 단위로 계산하되 동일 계약과 중복 합산하지 않습니다. 미래 하드웨어 매출과 연구지원금은 제외하겠습니다.

09. 스케일업 — 25초

강조 문장: 일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

화면 구성: 일상을 기록하는 환자·가족 이미지 영역을 중앙 기기 형태 안에 두고, 일상 기록의 활용·EMR/건강 앱·기기/바이오마커를 주변에 연결합니다. 작은 공통 관계도에서 환자 → EONU 흐름을 강조합니다. ADHD·노년층은 추가 연구 대상이며 연동이나 임상 검증 완료로 표시하지 않습니다.

대본:
의료진의 도입이 검증된 후에는 환자의 일상 정보가 진료에 얼마나 쓰이는지 살펴보겠습니다. 입력 부담과 반복 사용도 함께 봅니다. EMR과 외부 건강 앱 연결은 권한과 연동 비용을 확인해야 합니다. ADHD나 노년층에서의 기기 연동과 디지털 바이오마커는 대상별 접근성과 임상적 의미를 검토할 추가 연구 과제입니다.

10. 현재 진행·축적 자산 — 28초

강조 문장: 현장 피드백을, 첫 도입으로.

화면 구성: 현장 제품 검토 장면과 현재 접점 세 가지—정신과 전문의 피드백, 의료혁신 연구소 접점, 청년 우울증 관련 의료봉사 프로젝트—를 보여줍니다. 다음 검증은 실제 활용·업무 부담·지불 의사로 압축합니다. 상세 진행 상태표는 이 문서와 근거 등록부로 이동했으며 공식 제휴·실증·유료 계약 실적으로 표시하지 않습니다.

대본:
현재 자료에는 전문의의 지속적인 피드백과 기관 접점, 청년 우울증 관련 봉사 프로젝트 참여가 기재되어 있습니다. 이들을 실증이나 유료 계약 실적으로 합치지는 않았습니다. MVP 범위와 각 협력의 실제 상태는 증빙에 맞춰 확정하겠습니다. 다음에는 의료진의 실제 활용, 전체 업무 부담, 반복 사용과 구매 의사를 확인해 질문과 템플릿, 운영 경험을 축적하겠습니다.

11. 팀·1억 사용계획 — 32초

강조 문장: 1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

화면 구성: 1억 원 숫자를 중심으로 대표의 직접 기획·개발·수정 역할과 회색 사진 영역을 묶습니다. 사용 목적은 제품(개발·보안·운영), 실증, 고객 확보의 세 단계로 단순화했습니다. 배분액·기간·기관 수·유료 고객 수·CAC의 빈칸은 기획 문서에 보존하며 화면은 총액과 검증 목적에 집중합니다.

대본:
저는 의료와 AI에 대한 이해를 바탕으로 기획과 개발, 수정을 직접 이어갑니다. 임상 확인과 개인정보·보안, 실증 운영을 함께할 협력이 필요합니다. 1억 원은 제품, 보안, 실증, 고객 확보와 운영에 연결해 사용할 계획입니다. 항목별 배분과 기간, 실증 기관 수, 유료 고객 목표를 확정하고 고객 획득 비용까지 계산하겠습니다. 소개와 직접 접촉, 방문 데모와 파일럿으로 첫 유료 모델을 검증하겠습니다.

12. 마무리 — 15초

강조 문장: 환자에게 필요한 연결. 병원도 계속 쓸 이유.

화면 구성: 표지의 약속을 되받는 큰 마무리 문장과 EONU 브랜드, 일상과 진료의 순환 문장을 배치합니다. 환자·보호자·의료진 장면의 회색 이미지 영역과 작은 공통 관계도를 사용하고, 첫 병원군과 가치를 검증하겠다는 문장 및 연락처 입력 자리를 둡니다. 마지막 장에는 본문용 섹션 라벨과 페이지번호가 없습니다.

대본:
이어온유는 환자와 보호자가 원하는 연결을, 의료진도 지속적으로 참여할 이유가 있는 서비스로 만들겠습니다. 첫 병원군과 함께 실제로 쓰이고 지불할 가치가 있는지 검증하겠습니다. 감사합니다.

화면에서 덜어낸 발표 보완 정보

4~5장: 급여·비급여와 기존 홍보 방식

최신 MD는 병원 도입 가치 가운데 수익 기여를 초기 검증 대상으로 선택하고, 급여·비급여 중 비급여 관련 정보와 상담 연결에 주목합니다. v3 화면에는 '비급여 포함'을 보존합니다. 이것은 비급여 서비스의 적절성·수익 증가·상담 전환을 입증한 결과가 아닙니다. 진료 필요성 판단을 AI 요약이나 추천으로 대체하지 않습니다.

홈페이지·SNS·광고는 기존에 환자가 관련 정보를 접하는 경로입니다. EONU는 환자·보호자의 일상 기록에서 미해결 걱정을 구체화하고 병원이 제공한 관련 정보와 자발적인 상담 요청으로 이어지는 가치를 검증합니다. 기존 경로가 작동하지 않는다거나 EONU가 더 우수하다고 단정하지 않습니다. 상담 요청과 실제 매출, 기관의 지불 의사, 추가 업무 부담을 나누어 확인합니다.

이 설명은 질문에 답할 때 사용할 보완 정보이며 위 300초 배분의 대본에 추가된 문장은 아닙니다.

10장: 진행 상태와 다음 증빙

확인 항목	최신 자료가 말하는 범위	추가 확인할 자료
MVP	제공 범위·사용 가능 기능이 미정 입력 상태	현재 버전·구현/계획 기능·동작 기록
전문의 피드백	정신과 전문의의 지속 피드백 언급	참여 범위·기간·피드백과 반영 기록
기관 접점	의료혁신 연구소 관련 접점 언급	실제 관계·협의 단계·명칭 사용 범위
봉사 프로젝트	청년 우울증·자선사업 참여 확정 기재	역할·일정·참여 증빙
실증·유료 계약	기관 수·기간·계약 증빙 미제공	제한 실증 계획/결과·서명 계약·결제
법적 검토	범위·상태·결과 미제공	검토 범위·의견·완료일

'자료 미제공'은 실적이 없다는 뜻이 아닙니다. 확인된 접점과 계약 실적을 합쳐 제시하지 않기 위한 구분입니다. 다음 검증에서는 의료진의 실제 활용, 작성·확인·수정·후속 조치의 전체 업무 부담, 반복 사용, 유료 제안과 계약을 각각 측정합니다.

11장: 자금·기간·목표 입력 틀

사용 항목	금액	확인할 결과
제품 개발·개선	[ ]만 원	정한 업무에 사용할 수 있는 버전
개인정보·보안 검토	[ ]만 원	동의·공유·접근·데이터 처리 범위
제한 실증 설계·운영	[ ]만 원	[ ]개 기관의 활용·부담·반복 사용
고객 확보·방문 데모	[ ]만 원	[ ]개 유료 고객 목표와 구매 검증
API·클라우드·운영	[ ]만 원	운영 범위·반복 제공 원가
합계	**10,000만 원(1억 원)**	**[ ]개월 내 첫 유료 모델 검증**

고객 확보 경로는 소개·직접 접촉 → 방문 데모 → 파일럿 → 유료 제안입니다. CAC는 같은 기간 신규 고객 확보에 사용한 비용을 신규 유료 기관 수로 나눕니다. 제공 원가와 CAC, 투자·지원금은 구분합니다. 세부 배분과 목표가 미정이므로 비율 차트나 임의 숫자는 넣지 않았습니다.

리허설 기준

목표 배분 합계: **14 + 24 + 24 + 30 + 27 + 28 + 26 + 27 + 25 + 28 + 32 + 15 = 300초**.

실제 발화 문장 12개의 합은 **공백 포함 2,106자·493어절**입니다. 5분에 맞추려면 분당 약 420자를 말하는 속도에 해당하며, 이는 실측 발표 시간이 아닙니다. 각 장의 시작·종료와 전환 시간을 측정하고, 그림을 가리키거나 질문을 받는 시간은 별도로 확보합니다. 특히 4장과 11장의 분량을 리허설에서 확인합니다.

6장에 실제 서비스 시연을 추가하면 28초를 넘길 수 있습니다. 이 자료의 6장은 설명용 흐름이며 실제 제품 시연 시간을 포함하지 않습니다. 보완 표와 추가 설명을 낭독하면 목표 5분 밖의 시간이 필요합니다.

자료가 확정되면 MVP·협력 상태, 시장 입력값, 자금 배분·기간·실증/유료 고객 목표, 연락처를 갱신합니다. 목표는 실적과 구분하고 대본 변경 시 `slide.talk` 와 이 문서를 함께 수정한 뒤 다시 리허설합니다.

EONU IR v3 근거·가정·미확정 항목 등록부

기준일: 2026-10-21. 이 등록부는 첨부 자료의 내용을 분류한 것으로, 외부 사실 검증을 완료했다는 뜻이 아닙니다.

출처와 우선순위

ID	자료	날짜/상태	적용
U01	이번 사용자의 직접 요청 및 후속 선택	2026-10-21	HTML 와이어프레임·시안 각각 12장, 6장 데모 진행 흐름 포함, 이미지 회색 placeholder, 본문 공통 섹션 제목, 별도 폴더, ZIP/PDF/grid, GitHub 업로드·재다운로드 검증
S01	`01_PPT내용과_대본.md`	제목상 2026-10-20 정리본	페이지 내용·순서의 최신 기준
S02	`EONU_IR_페이지별외주요청서_현재기준_13p (1).pptx`	문서상 2026-10-14	설명 보완과 과거 기획 비교; S01과 충돌하면 S01 우선
V01	사용자 첨부 첫 이미지	메신저 흐름 와이어프레임	회색 블록, 얇은 선, 흐름 연결의 스타일 참고
V02	사용자 첨부 나머지 이미지	밝은 배경·라운드 카드·푸른 강조	시안 스타일 참고. 이미지 안의 외식업 통계는 EONU 데이터가 아님
U02	후속 디자인 강화 요청	v2 재디자인	구도·여백·서체 위계·이미지 영역, Pretendard·4px/2px 규격, 표지/마무리의 섹션 제외
U03	최신 디자인 개선 요청 및 첨부 6장	v3 재디자인	복잡한 화면을 줄이고 짧은 헤드라인·대표 시각 요소를 강화. 상세 관리표·입력 틀은 문서에 보존
V03	최신 사용자 첨부 이미지	교육·조직개발·AI 프로젝트·IDGE 발표 디자인	밝은 여백·중앙 UI/오브젝트·부드러운 카드·짧은 강조의 시각 참고. 이미지 안 수치·로고·실적을 EONU 데이터로 사용하지 않음

문서 속 제작 메모와 링크는 참고 정보입니다. 계정 접근·전송·게시 등의 실행 권한은 U01에 근거합니다. 위 자료에 언급됐으나 업로드되지 않은 멘토링·발화 원문 파일은 읽지 않았습니다.

사실 수준의 구분

- **자료 확인:** 첨부 자료에 어떤 내용이 쓰여 있는지 확인했습니다.
- **원문 주장:** MD/PPTX 작성자가 기술한 제품·인물·기관 관련 주장입니다. 외부 증빙 확인 전입니다.
- **사업 가설:** 앞으로 측정하거나 구매자에게 검증할 기대 효과입니다.
- **개선 제안:** 이번 개선본이 추가한 정의·검증 방법·표현 구조입니다.
- **미확정:** 원문이 공란으로 남겼거나 최신 증빙이 제공되지 않은 항목입니다. 미확정은 '0'이나 '없음'을 뜻하지 않습니다.

주장별 등록부

항목	분류	근거	덱에서 허용하는 표현	확정에 필요한 자료
EONU/이어온유 서비스명	자료 확인	S01·S02	서비스명 사용	최종 브랜드 표기 변경 시 갱신
환자·보호자·의료진 연결	사업 방향	S01 1~3장	만들고자 하는 AI 소통 서비스	실제 제공 범위와 사용 결과
혼자 진료받는 아이의 상황	재구성 사례	S01 2장·메모 8	'재구성한 예시'	실제 인터뷰를 쓸 경우 기록·사용 범위
진료 시간 '3분'	원문 표현, 외부 확인 전	S01 3장 대본	정량 표현을 빼고 '짧은 진료 시간'	진료과·대상·시점이 맞는 통계
의료진 도입 가치 3가지	사업 가설	S01 4장	효율·임상 활용·수익 기여를 검증	업무 관찰·정량 실증·유료 제안 결과
비급여 관련 상담 연결	사업 가설	S01 핵심 사업 논리	환자의 정보 탐색·상담 요청 흐름을 검증	적격 분모, 상담 요청·관련성·부담·결제 근거
AI 요약, 달력, 음성, 공유 범위	기능 설계, 구현 상태 미확정	S01 5~6장	설명용 기능 흐름	실제 버전·동작 검증·제공 기능 목록
EMR 연동	후속 확장	S01 9장·메모 5	연동 검토	연동 계약·기술 구현·운영 확인
일차의료기관 B2B 라이선스	사업 모델 가설	S01 7장	첫 매출 경로	첫 고객군·구매자·가격·계약 조건
B2B2C	후속 사업 모델	S01 7~8장	추가 유료 가치 검토	상품 정의·전환·유지·과금 검증
B2G	별도 사업 모델	S01 7~8장·메모 9	공공 구매자와 계약 검증	실제 발주기관·조달 경로·계약
TAM·SAM·SOM 수치	미확정	S01 8장	정의·산정식·입력 자리	기관 수 출처·필터·가격·기간·중복 기준
ADHD·노년층	확장 방향	S01 9장	입력과 활용을 추가 검증할 대상	대상별 참여·효용·구매 조건
기기·디지털 바이오마커	연구·개발 방향	S01 9장	추가 연구 과제	연구 설계·근거·적용 경로
MVP 상태	미확정	S01 10장 [MV상태]	보완 문서의 MVP 상태 확인 항목	현재 버전·기능·배포 범위
서울대 정신과 전문의의 지속 피드백	원문 주장	S01 10장 메모	'전문의 피드백: 범위·증빙 확인'	참여자·기간·피드백 내용·공개 허용 범위
도헌디지털의료혁신연구소	기관명 기재, 관계 미확정	S01 10장 메모	기관 협의 상태 확인 항목	실제 관계·범위·현재 단계·명칭 사용 범위
의료봉사 단체 프로젝트 참여 확정	원문 주장	S01 10장 메모	'원문상 참여 확정, 범위·증빙 확인'	단체·프로젝트·역할·일정·참여 증빙
실증·유료 계약·매출	미확정	S01 10장·서두	각각 별도 확인	실증 기록·서명 계약·청구/입금 자료
법적 검토	상태 미확정	S01 10장	보완 문서의 검토 상태 확인 항목	검토 범위·일자·결과
직접 기획·개발·수정 역량	원문 주장	S01 11장	역할 설명	제품·수정 사례·실행 기록
대표 이동원·학력·교육·연구 이력	과거 자료의 원문 주장	S02 12장	최신 이력 확인 후 사용	재학/활동 상태·최종 소개 문구
요청 규모 1억 원	자료 확인: 계획 금액	S01 11장	'1억 원으로 첫 유료 모델 검증'	실제 투자 요청 조건·세부 집행 계획

항목	분류	근거	덱에서 허용하는 표현	확정에 필요한 자료
1억 배분·집행 기간·목표·CAC	미확정	S01 11장	화면은 총액·목적, 문서에는 대괄호와 항목별 입력 틀	예산·현금흐름·실증/계약 목표·영업 비용
연락처	미제공	S01 12장	[연락처 입력]	공개 가능한 이메일/전화/사이트

참고 링크의 사용 범위

아래는 S01에 기재된 링크이며 이번 기획 검토에서는 링크의 현재 페이지 내용·최신 수치·서비스 기능을 독립 검증하지 않았습니다.

링크	원문에서의 목적	적용 제한
TV조선, 2023-07-26	소아 단독 내원 관련 사회적 맥락	설명 부족 빈도·문제 증가·시장 크기의 직접 근거로 쓰지 않음
강남언니 안내	시술 정보·광고·상담 방식 참고	EONU 우월성이나 경쟁사의 전체 기능 제한을 입증하지 않음
AfterDoc	환자관리·재진 마케팅 참고	CRM 전반의 기능을 단정하지 않음
국민건강보험 비급여 안내	비급여 개념	개별 치료의 적절성·수요·전환 성과를 입증하지 않음

MD와 PPTX의 주요 차이

쟁점	과거 PPTX	최신 MD	이번 개선본의 처리
전체 구성	13장	12장 번호, 6장 미제작 메모	사용자의 후속 선택에 따라 각각 12장, 6장 데모 진행 흐름 포함
의료진 참여	첫 MVP·대상 선정·사업 설명에 분산	참여 이유와 비급여 연결을 4장으로 통합	4장의 사업 가설을 선명하게 정리
첫 고객	부모-청소년 등 탐색 맥락	초기 병원군 선정 중, ADHD·노년층 확장	특정 질환·인구를 확정 타깃으로 승격하지 않음
제품 데모	합성 화면·구현 상태 구분	6장 설명은 있으나 '만들지 않습니다'	사용자 결정에 따라 6장에 데모 진행 흐름 포함; 구현 증빙 없는 기능은 설명용 설계로 표시
현재 협력	협력 확보 중	전문의 피드백, 기관명, 프로젝트 참여 확정 메모	최신 언급을 보존하되 관계·범위·실증·계약을 별도로 구분
투자	요청 금액·기간 후속 계산	1억 원, 배분·기간·목표 미확정	합계 1억을 반영, 비율·기간·목표는 임의 생성하지 않음
팀	이름·학력·강화학습·교육 이력 구체적	직접 기획·개발 역량 중심	최신 MD 중심; 과거 이력은 확인 필요 목록에 보존
시장	상품별 계산 계획	현재 소프트웨어 TAM·SAM·SOM	기관 수×연간 가격, 실제 확보 목표 분리

이번 개선본이 추가한 제안

1. 첫 고객군의 필터: 반복 진료 정보 수요, 병원이 정할 수 있는 질문/안내, 실증·유료 제안에 참여할 구매자.
2. 경쟁 대안 비교 방식: 경쟁사 기능을 단정하는 대신 현장에서 확인할 대체 가능성 질문.
3. 검증 지표의 분자·분모: 전달 완료, 실제 활용, 전체 업무 부담, 관련 상담 요청, 반복 사용, 유료 계약.
4. 시장 계산 정의: TAM/SAM은 현재 소프트웨어의 적격 범위, SOM은 기간 내 유료기관 확보 목표에 근거한 연간 환산 규모.

5. 비용 구분: 제공 원가·고객 획득비·연구비·투자·지원금을 분리.
6. 1억의 항목-산출물 연결과 목표 시간 300초의 발표 배분안. 대본은 `src/slides.js` 와 동기화했으며 발화 분량은 공백 포함 2,106자·493어절입니다. 실제 낭독 시간은 아직 측정하지 않았습니다.

이 항목들은 현재 실적이 아니라 개선을 위한 설계 제안입니다. 일부 세부 지표·계산 정의·경쟁 대안 비교는 `planning-review.md` 의 보완 자료에 있으며, 모든 세부 내용을 12장 슬라이드에 표시한 것은 아닙니다. 슬라이드의 제품 흐름은 구현 완료의 증거가 아닌 설명용 도식입니다.

채워 넣을 데이터 체크리스트

묶음	입력 필드	권장 확인 방법
고객	진료과·지역·기관 규모·주사용자·구매 결정자·예산	실제 인터뷰/접촉 기록
제품	현재 버전·가능 기능·계획 기능·연동 여부	동작 확인·릴리스 기록
진척	피드백·협의·참여·실증·계약·매출 각각의 날짜/범위	문서·회의 기록·서명 자료·입금
시장	기관 수 출처·기준일·필터·가격·목표 기간·중복 규칙	공식 기관 통계·가격 제안·파이프라인
유닛 이코노믹스	기관별 제공 원가·유료 가격·영업 인력시간·직접 비용	사용량·회계·영업 활동 로그
자금	제품·보안·실증·고객 확보·운영 배분, 월별 소진	견적·집행 계획·현금흐름표
목표	실증 기관·유료 고객·활용·부담·반복 사용 기준	사전 합의된 실증 계획
공개 정보	대표 최신 이력·기관명/로고 사용 범위·연락처	당사자 확인

시각화 데이터 규칙

미확정 수치는 0으로 바꾸지 않습니다. 시장 포함 도형과 사업 단계 도식은 정성 구조입니다. 예산은 합계 1억만 확정된 계획으로 보여주며, 비율이 미정인 항목에 임의 너비의 누적막대나 도넛 조각을 만들지 않습니다. 수치가 확정되면 데이터 입력과 표시를 함께 수정하고 합계·단위·축·분모를 다시 검수합니다.

v3 시각 구성과 데이터 경계

- 본문 2~11장은 공통 섹션 라벨·제목·페이지번호 체계를 사용합니다. 표지와 마지막 장에는 섹션 라벨과 페이지번호가 없습니다.
- 이미지 영역은 한 덱당 11개입니다. 1장 1개, 2장 2개, 3장 3개, 5·9·10·11·12장에 각각 1개이며 전부 `#e5e5e5` 단색 회색 placeholder입니다. 장면 설명은 실제 사진이나 사례 증빙이 아닙니다.
- 3장은 큰 세 주체 관계도, 5·9·12장은 같은 역할을 유지한 작은 맥락도입니다. 6장의 데모 UI, 7장의 사업 분기, 8장의 시장 포함 관계는 실제 HTML/SVG로 구현합니다. 시장 도형 크기는 시장금액의 비율이 아닙니다.
- 2장의 네 이야기 단계는 진료실 안/밖의 두 큰 장면으로 묶었습니다. 사건 수나 사실 범위를 바꾼 것은 아닙니다. 설명용 사례라는 표시를 유지합니다.
- 10장의 진행 상태표, 11장의 배분·기간·목표 입력 틀은 보완 문서로 옮겼습니다. 세부 내용은 `revised-script.md` 와 `planning-review.md` 에서 확인할 수 있습니다. 화면에서 빈칸을 줄인 것은 숫자가 확정됐다는 뜻이 아닙니다.
- Pretendard와 4px 배치 단위·2px 선/세부 조정을 적용합니다. 12개 대본은 v2와 같으며 새 시장 수치·가격·기관 실적·투자 배분을 추가하지 않았습니다.
- 문서의 강조 문장은 `src/slides.js` 를 실행해 초기 메타데이터에 `set(n, ...)` 를 적용한 최종 제목을 기준으로 합니다. 화면의 짧은 상태 표시와 발표 대본·근거 등록부는 함께 읽는 구조입니다.